

يُسبب مرض بيروني تكوّن ندبة (الويحة) داخل القضيب تحدث انحناءً أثناء الانتصاب، مما قد يُعسر الجماع. يُقوّم تطبيق القضيب هذا الانحناء بوضع غُرز على الجانب الأطول للقضيب لـ"طيّه" برفق حتى يتساوى مع الجانب الأقصر. تشرح هذه النشرة آلية عمل الإجراء وكيفية التحضير وما يمكن توقعه.

عن هذا الإجراء

في مرض بيروني، تشدّ الأنسجة الندبية أحد جانبي القضيب فيحدث انحناءً عند الانتصاب. يُقوّم التطبيق الانحناء بخياطة وتقصير الجانب الأطول (الخارجي) من القوس حتى يتساوى الجانبان. لا تُستأصل الندبة ولا يُستخدم أي طعم — فهذه أبسط عمليات التقويم وأقصرها، وتنطوي على أدنى خطر للإصابة بمشكلات انتصاب جديدة.

يُعدّ الإجراء خياراً مناسباً عندما:

- يكون الانحناء معتدلاً وغير معقّد
- تكون الانتصابات جيدة (بمساعدة الأدوية أو بدونها)
- يكون القضيب طويلاً بما يكفي لتقبّل تقصير طفيف

ما تحتاج معرفته

المقايضة الرئيسية هي **تقصير** القضيب — عادةً نحو 2-1 سم. كثيراً ما يبالغ المرضى في تقدير هذا التقصير؛ إذ يكون الطول القابل للاستخدام بعد تصحيح الانحناء مشابهاً للحالة السابقة. يحصل نحو **9 من كل 10** رجال على انتصاب مستقيم كافٍ للجماع. قد تشعر بالغرر تحت الجلد (أمر شائع وعادةً غير مزعج). الهدف تقويم القضيب بما يكفي لجماع مريح، لا بالضرورة تقويم تام.

تعلم المصطلحات

مرض بيروني

ندبة داخل القضيب تحدث انحناءً أثناء الانتصاب.

الويحة

بقعة الأنسجة الندبية المسببة للانحناء.

التطبيق (Plication)

تقويم القضيب بخياطة وتقصير الجانب الأطول.

الانتصاب الاصطناعي

انتصاب يُحدث في غرفة العمليات بالحقن لتمكين الجراح من قياس الانحناء والتحقق منه.

الختان

استئصال القلفة — قد يُجرى في الوقت ذاته إن لم تكن مختوناً.

جهاز الشفط (Vacuum device)

مضخة قد تُستخدم أثناء الشفاء للمساعدة في الحفاظ على الطول والانتصاب.

التخدير العام

دواء يُيقّيك نائماً وخالياً من الألم طوال الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت تخدير عام أو شوكي أو موضعي، فلا تشعر بأي ألم أثناءها. بعدها تُوَفَّق تورُّماً وكدمات وألماً في القضيب لمدة 2-1 أسابيع — يُساعد الثلج والملابس الداخلية الداعمة ومسكنات الألم. العملية قصيرة (نحو ساعة عادةً) وتُجرى في الغالب في اليوم ذاته. قد تُوضَع قسطرة لفترة وجيزة.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

بعد الجراحة

- تُجرى تحت تخدير عام أو شوكي أو موضعي — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف الأدوية المُحدّدة بما فيها مرُقّقات الدم).
- يجب أن يكون مرض بيروني لديك مستقرّاً (ثبات الانحناء وزوال الألم لعدة أشهر) — يُؤكّد جراحك ملاءمة التوقيت.
- لا تدخّن؛ تُعالج أي عدوى أولاً وتُعطى المضادات الحيوية. إن لم تكن مختوناً فقد يُجرى الختان في الوقت ذاته — استفسر من جراحك.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تعاني من ضعف الانتصاب أو تتناول دواءً لتحسينه
- تتناول مرُقّق دم، أو أجريت جراحة سابقة في القضيب

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تكون نائماً أو مخدّراً، وتُعطى لك المضادات الحيوية.
- 2 يُحدّث انتصاب بالحقن ليرى الجراح الانحناء، ثم تُوضَع غُرز على الجانب الأطول لطّي القضيب وتقويمه.
- 3 يُتحقّق من النتيجة بانتصاب آخر، ثم يُغلّق الجلد (وقد يُجرى الختان في الوقت ذاته عند الحاجة).

- تُوَفَّق تورُّماً وكدمات وألماً لمدة 2-1 أسابيع. استخدم الثلج والملابس الداخلية الداعمة ومسكنات الألم، وحافظ على نظافة المنطقة.
- إن وُضعت قسطرة، تُزال عادةً صباح اليوم التالي للجراحة.
- تجنّب الجماع لنحو 4-6 أسابيع حتى يلتئم الإصلاح.
- قد يوصي فريقك بتناول جرعة منخفضة من دواء الانتصاب و/أو استخدام جهاز الشفط يومياً أثناء الشفاء للمساعدة في الحفاظ على الطول والانتصاب.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو شعيرة، أو احمرار أو ألم أو تورّم أو إفرازات متزايدة في موضع الجرح
- عجز عن التبول
- تورّم أو ألم شديد أو متفاقم، أو نزيف غزير

ثلاثة أمور تدكّرهما

1. يُقوّم التطبيق الانحناء بخياطة الجانب الأطول للقضيب — دون استئصال الندبة أو استخدام طعم. هو أبسط عمليات التقويم وأدناها خطراً لمشكلات الانتصاب.
2. المقايضة هي تقصير طفيف (عادةً 2-1 سم)، غير أن تصحيح الانحناء كثيراً ما يُعيد الطول القابل للاستخدام؛ ويحصل نحو 9 من كل 10 رجال على انتصاب كافٍ. قد تشعر بالغُرز تحت الجلد.
3. يجب أن يكون المرض مستقرّاً أولاً؛ لا تدخّن. بعدها تجنّب الجماع نحو 4-6 أسابيع واتّبع خطة الشفاء (الدواء/جهاز الشفط). اتصل عند حدوث حمى أو تورّم شديد أو صعوبة في التبول.